

3 横隔膜腫瘍 diaphragmatic tumor

到達目標

- 横隔膜腫瘍の種類とその特徴について説明できるようになる

病因・病態・疫学

横隔膜腫瘍はまれな疾患であり，良性腫瘍（嚢胞や脂肪腫など）と，悪性腫瘍（横紋筋肉腫などの肉腫）に大別される．また，悪性中皮腫や卵巣癌など，胸腔・腹腔内の悪性腫瘍が横隔膜に浸潤・播種したものも鑑別に重要である．

Kim ら（2009）は，144 例の横隔膜腫瘍を集計し，その組織型の頻度を報告している¹⁾（表 1）．良性では嚢胞（cyst）が最多であり，mesothelial cyst および bronchogenic cyst に分類される．次いで，脂肪腫（lipoma），神経線維腫，血管腫などが報告されている．悪性腫瘍では横紋筋肉腫（rhabdomyosarcoma）が最多で，次いで線維肉腫（fibrosarcoma）が多いとされる．

Guo らの単施設研究では，18 例中 11 例が横隔膜角（diaphragm angle）に発生しており，この部位の腫瘍の好発性が示唆されている²⁾．

また，Baltes らの報告によれば，原発性腫瘍よりも胸腹腔からの続発性腫瘍（secondary tumor）の方が多いとされる³⁾．日本からは松村らが 1983 年に 40 例の集計を報告しており，海外報告と類似の傾向がみられた⁴⁾．

発見年齢は新生児から高齢者まで幅広く，平均は 40 歳前後である．性差や左右差は特に認められていない．

症状・身体所見

良性腫瘍の多くは無症候性であり，検診などで偶然発見される．一部では，胸痛・咳嗽・呼吸困難などの症状が現れることがある．

悪性腫瘍では，肺や心臓，胸腹壁への浸潤や圧迫によって，血痰，不整脈，背部・腰部痛などの症状がみられることがある．胸水を伴う場合には，呼吸音の減弱など身体所見として認められることもある．

表 1 横隔膜腫瘍の種類と頻度（144 症例）

良性腫瘍	数	悪性腫瘍	数
cyst	38	rhabdomyosarcoma	15
lipoma	13	fibrosarcoma	9
neurofibroma	5	neurofibrosarcoma	3
angiofibroma	3	sarcoma, undifferentiated	3
fibroma	3	york sac tumor	3
hemangioma	3	extraskletal Ewing's sarcoma	2
schwannoma	3	fibromyosarcoma	2
others	14	others	15

[Kim M, et al : Thorac Surg Clin 19 : 521, 2009 より作成]

診断・検査

胸部 X 線（正面・側面），CT，MRI，超音波検査，血管造影などを組み合わせて診断を進める．胸水を伴う症例では，胸水細胞診が有用である．

腫瘍が横隔膜原発かどうかの判別は難しく，CT ガイド下針生検を行っても確定診断が困難なことが多い．そのため，診断と治療を兼ねた外科的切除・生検が選択されることが多い．

治療

基本的には，確定診断および治療のために外科的切除を行う．

良性腫瘍では切除のみで治療完結可能である．

悪性腫瘍や周囲臓器への浸潤がある場合は，化学療法・放射線療法を併用することもある．

ただし，組織型に応じた標準的治療法はいまだ確立されておらず，個別の対応が必要である．

文 献

- Kim MP, Hofstetter WL : Thorac Surg Clin 19 : 521, 2009
- Guo C, et al : Thorac Cancer 12 : 1810, 2021
- Baltes N, Schirren J : Thorac Cardiovasc Surg 64 : 641, 2016
- 松村 吉ほか : 日小外会誌 19 : 719, 1983